

Uzależnienie + *zaburzenia osobowości*

30–50% osób z uzależnieniem ma zaburzenie osobowości — najczęściej *borderline* lub *antyspołeczne*. Leczenie obu wymaga dłuższego horyzontu czasowego.

CZAS: 25 min czytanie Psychoedukacja + plan

ŹRÓDŁO: Trull i wsp. (2018); Verheul (2001, metaanaliza); APA wytyczne (2018)

JAK UŻYWAĆ

Karta wprowadza wiedzę o **współwystępowaniu zaburzeń osobowości i uzależnienia**: 1) najczęstsze zaburzenia (BPD, ASPD, NPD, AVPD), 2) wspólny mianownik — **impulsywność i regulacja emocji**, 3) podejścia terapeutyczne (DBT, ST, MBT), 4) różnica między „*cechą*” a „*zaburzeniem*”. Karta nie diagnozuje — pełna diagnostyka zaburzeń osobowości wymaga 2–3 sesji z doświadczonym klinicystą i wywiadu strukturyzowanego.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Trull i wsp. (2018, n=43 093, badanie populacyjne NESARC) wykazali: **30–50% osób z uzależnieniem alkoholowym** ma zaburzenie osobowości — najczęściej BPD (zab. osobowości *borderline*), ASPD (zab. *antyspołeczne*), NPD (narcystyczne) i AVPD (unikowe). Verheul (2001, metaanaliza 23 badań): zaburzenie osobowości jest **najsilniejszym predyktorem wczesnego nawrotu** (HR 2,3) i **słabej odpowiedzi na klasyczną terapię CBT**. Mechanizm: wspólny wymiar *impulsywności* + *emocjonalnej dysregulacji*. Klasyczne podejścia uzależnień zakładają stabilną osobowość — gdy jej brak, terapia musi zacząć od *budowania umiejętności regulacji* (DBT, ST), dopiero potem klasyczna praca nad używaniem.

01 📋 Cztery najczęstsze zaburzenia + uzależnienie

BPD · BORDERLINE

15–25% u uzależnionych

Niestabilność afektu, relacji, tożsamości. Impulsywność. Lęk przed porzuceniem. **Substancja:** regulacja silnych emocji + lęk przed pustką. **Terapia:** DBT (Linehan), terapia schematów.

ASPD · ANTYSPOŁECZNE

15–20% u uzależnionych

Łamanie norm społecznych, brak skruchy, impulsywność, agresja. **Substancja:** wzmacnia odhamowanie, łatwiejsza droga. **Terapia:** wymaga ścisłej struktury — CRA, programy społeczności terapeutycznych.

NPD · NARCYSTYCZNE

5–10% u uzależnionych

Grandiozyjność, brak empatii, potrzeba podziwu. Wrażliwość na krytykę. **Substancja:** regulacja wstydu po porażce / krytyce. **Terapia:** wymaga dłuższej pracy nad wstydem (terapia schematów, TFP).

AVPD · UNIKOWE

10–15% u uzależnionych

Unikanie kontaktów społecznych z lęku przed odrzuceniem. Niska samoocena. **Substancja:** redukuje lęk społeczny, „odważnik” do rozmowy. **Terapia:** CBT + ekspozycja społeczna, terapia schematów.

02 ☉ Wspólny mianownik — dwa wymiary

WYMIAR 1 · IMPULSYWNOŚĆ

Słonność do natychmiastowego działania bez planowania konsekwencji. Mózg uzależniony i mózg BPD/ASPD *działają podobnie*: spadek aktywności kory przedczołowej, deficyt hamowania. To **biologiczny wymiar** — częściowo wrodzony, częściowo wzmacniany przez używanie.

WYMIAR 2 · DYSREGULACJA EMOCJI

Trudność z tolerowaniem silnych emocji. Brak „wewnętrznego termostatu”. Emocja od 0 do 10 w sekundach. Substancja staje się **zewnętrznym regulatorem** — szybkim, skutecznym, ale z kosztem długoterminowym (eskalacja, tolerancja, uzależnienie).

03 Co działa — etapowe podejście

ETAP	CZAS TRWANIA	CELE I METODY
1 · Stabilizacja	3–6 mies. → 1 rok	Abstynencja (lub redukcja szkód), bezpieczeństwo, podstawowe umiejętności DBT (uwaga, tolerowanie stresu)
2 · Praca nad schematami	1–3 lata	Terapia schematów (ST), DBT, MBT (mentalizacja), praca z wczesnymi doświadczeniami
3 · Integracja	Długoterminowo	Budowanie życia — relacje, praca, hobby, sens. Grupy wsparcia. Niska intensywność, ale bezterminowo

Realistyczny horyzont: leczenie zaburzenia osobowości + uzależnienia zajmuje **3–7 lat**. Krótsze interwencje (8 tyg., 6 mies.) dają tylko stabilizację. Pełna remisja wymaga długiej pracy nad wzorcami osobowości. **To nie wada pacjenta** — to natura tego typu zaburzeń. Bamelis i wsp. (2014, RCT n=323): po 3 latach terapii schematów **43% pełnej remisji** zaburzenia osobowości — wynik niewiele mniejszy niż przy depresji bez współwystępowania.

04 Cecha czy zaburzenie — kluczowe pytanie

WZORCE, KTÓRE ROZPOZNAJĘ U SIEBIE

— które z 4 zaburzeń mi rezonuje

OD KIEDY OBECNE

— czy od zawsze, czy dopiero w czasie używania

CZY WYSTĘPUJĄ TEŻ W ABSTYNENCJI

— np. w okresach trzeźwości

CO OMÓWIĘ Z TERAPEUTĄ

— pytanie o diagnostykę

Klucz: Verheul (2001) i Trull i wsp. (2018) podkreślają: **diagnostyka zaburzenia osobowości w trakcie aktywnego używania jest zawodna**. Wiele cech (impulsywność, niestabilność afektu, problemy w relacjach) jest *również objawem* uzależnienia. Wiarygodna diagnoza wymaga 6+ miesięcy stabilizacji. Stąd kolejność: **najpierw redukcja używania → potem diagnoza osobowości → potem długoterminowa terapia**. To nie znaczy „odłóż wszystko” — pierwsze umiejętności DBT (uwaga, tolerowanie stresu) wprowadzamy od początku, bo pomagają zarówno z uzależnieniem, jak z dysregulacją.